Artritis y polimialgia por inhibidores de checkpoint: ¿quién necesita algo más que esteroide?

Liapi M, Dastmalchi M, Svedman FC, Chatzidionysiou K. Treatment patterns and outcomes of immune checkpoint inhibitor-induced inflammatory arthritis and polymyalgia rheumatica: a single-centre observational study. *RMD Open*. 2026;12:e007219. doi:10.1136/rmdopen-2026-007219

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Ayuda a anticipar

Sugiere distinguir dos fenotipos: la polimialgia suele controlarse con dosis bajas de esteroide; la artritis requirió FARME en ~la mitad. Es útil para planear, no para cambiar el algoritmo.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Descriptivo, sí

68 pacientes consecutivos de un solo centro, con seguimiento a 12 meses. Describe bien qué se hizo, pero no puede demostrar que los FARME funcionaron.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Sin comparador ni desenlace oncológico

La mejoría puede deberse al tiempo o al retiro del inhibidor. No se reportaron respuesta tumoral ni supervivencia. La actividad se calificó con grados CTCAE, sin un índice compuesto validado, por el propio reumatólogo.

En 30 segundos. En el Hospital Universitario Karolinska se revisaron 68 pacientes enviados por oncología entre 2020 y 2025, con **artritis** (± síntomas de polimialgia; n = 50) o **polimialgia sola** (n = 18) por inhibidores de checkpoint. Mediana de edad 75.6 años; sobre todo melanoma (40 %) y carcinoma renal (32 %). Todos recibieron glucocorticoide primero (mediana de 10 mg/día de prednisolona). **Ninguno con polimialgia sola necesitó un FARME**: 78 % estaba en remisión a los 3 meses. En la artritis, **26 de 50** pasaron a un segundo fármaco (metotrexato 14, tocilizumab 9) y 9 a un tercero. La remisión en la artritis subió de 36 % a 64 % a los 12 meses, y el 50 % estaba sin esteroide. El inhibidor se suspendió por el evento reumático en el **46 %** de las artritis contra el 11 % de las polimialgias.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer una serie retrospectiva de tratamiento: qué se puede concluir sin grupo comparador, por qué "mejoraron después de iniciar el fármaco" no prueba que el fármaco funcionó (regresión a la media e historia natural), qué es la confusión por indicación y por qué importa el desenlace que falta (aquí, el cáncer).

1 La pregunta clínica

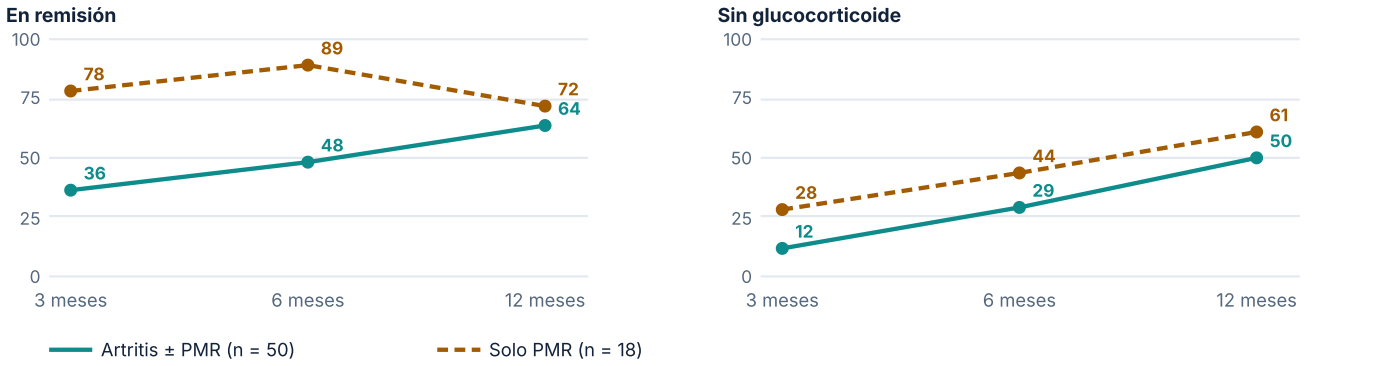
POBLACIÓN	69 pacientes consecutivos enviados a reumatología por sospecha de evento adverso reumático por inhibidor de checkpoint, de enero de 2020 a abril de 2025; se excluyó 1 con AR previa. Artritis confirmada por clínica y ultrasonido (60 % poliartritis, 26 % oligoartritis, 14 % monoartritis). Polimialgia por clínica y, en algunos, ultrasonido o PET-TC. 43 % mujeres; 54 % con cáncer metastásico. Inhibidores: nivolumab 50 %, pembrolizumab 22 %, ipilimumab + nivolumab 15 %. Mediana de 4 meses del inicio del inhibidor al evento.
TRATAMIENTO	Glucocorticoide en todos; escalamiento a FARME convencional o biológico según el criterio del reumatólogo tratante (no protocolizado).
COMPARADOR	Ninguno para el tratamiento. Se compararon los dos fenotipos y, en un análisis secundario, el cáncer metastásico contra el no metastásico.
DESENLACES	Actividad a los 3, 6 y 12 meses por grados CTCAE (0 = remisión, sin síntomas ni inflamación de laboratorio y con prednisolona ≤5 mg/día), estar sin esteroide, necesidad de segunda y tercera línea, y suspensión del inhibidor por el evento.

2 Diseño

TIPO	Cohorte retrospectiva unicéntrica, con revisión de expedientes según una lista de datos predefinida. Seguimiento mínimo de 12 meses.
ESTADÍSTICA	Descriptiva; ji cuadrada, Fisher y Mann-Whitney para comparar los fenotipos. Sin modelos ajustados.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Fondos académicos y gubernamentales suecos (Karolinska Institutet, Consejo Sueco de Investigación, ALF y una fundación). Sin conflictos declarados.

3 Resultados

Evolución por fenotipo (%)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto y de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN	ARTRITIS ± PMR (N = 50)	SOLO PMR (N = 18)
Prednisolona inicial, mediana (RIC)	15 mg (10–22.5)	10 mg (10–16.25)
Segunda línea	26 (52 %*): metotrexato 14, tocilizumab 9, hidroxicloroquina 1, etanercept 1, anakinra 1	0
Tercera línea	9 (18 %*): metotrexato 5, tocilizumab 4	0
Suspensión del inhibidor por el evento reumático	23 (46 %)	2 (11 %); p = 0.01
Actividad alta al inicio	36 %	17 % (p = 0.217)
Otros eventos inmunitarios concomitantes	27 (53 %)	7 (39 %)

*El artículo reporta 54 % y 19 %; con un denominador de 50, 26 y 9 corresponden a 52 % y 18 %. Cáncer metastásico vs. no metastásico: similar necesidad de segunda línea (35 % vs. 40 %) y remisión a 12 meses de 68 % vs. 79 %. Anticuerpos: 25 % con alguno positivo (ANA 10, FR 4, anti-CCP 2), con datos faltantes.

4 Cómo leer estos resultados

- **Dos fenotipos distintos.** DATO DEL ARTÍCULO La polimialgia sola respondió al esteroide sin escalar (78 % en remisión a 3 meses), aunque la remisión bajó de 89 % a 72 % entre los 6 y 12 meses, al bajar el esteroide. La artritis escaló en ~la mitad. INTERPRETACIÓN Es coherente con otra cohorte multicéntrica citada por los autores. Ante una artritis por inhibidor, conviene anticipar desde el inicio que puede necesitar un ahorrador de esteroide.
- **"Los FARME fueron muy eficaces" es más de lo que el diseño permite.** DATO DEL ARTÍCULO La remisión de la artritis subió de 36 % a 64 % mientras se escalaba el tratamiento. INTERPRETACIÓN Sin un grupo que no recibiera FARME, esa mejoría puede reflejar historia natural, regresión a la media (se escala cuando el paciente está peor) o la suspensión del inhibidor (46 %). Es una observación, no una medida de eficacia.
- **Confusión por indicación.** INTERPRETACIÓN Quien recibió FARME era, por definición, quien no respondía al esteroide. Comparar a los tratados con los no tratados mezclaría el efecto del fármaco con la gravedad que motivó usarlo.
- **Falta el desenlace que más importa al oncólogo.** DATO DEL ARTÍCULO No se reportan respuesta tumoral, progresión ni supervivencia; los autores lo plantean como pregunta abierta. INTERPRETACIÓN La razón para evitar dosis altas de esteroide, y para dudar de los biológicos, es su posible efecto sobre el control del cáncer. Sin ese dato, no se puede decir que escalar sea "seguro" para el tumor.
- **¿Cuántos casos leves quedaron fuera?** DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen que los casos más graves pudieron enviarse a reumatología y los leves quedarse con oncología. Otras series reportan uso de FARME de 11 % a 42 %. INTERPRETACIÓN El 52 % de escalamiento probablemente sobreestima lo que se vería en todos los pacientes con artritis por inhibidor.

CONCEPTO CLAVE · SERIES DE TRATAMIENTO SIN COMPARADOR

Antes y después no es causa y efecto: que un paciente mejore tras iniciar un fármaco puede deberse al fármaco, a la evolución natural, a otras intervenciones simultáneas (aquí, suspender el inhibidor o ajustar el esteroide) o a la **regresión a la media**: si se escala en el peor momento, lo más probable es que después mejore de todos modos. **Confusión por indicación:** los tratados

difieren de los no tratados justo en la razón del tratamiento. **Medición:** grados CTCAE asignados por el médico tratante, sin cegamiento y sin un índice compuesto validado para estos eventos, se prestan a sesgo de medición. **Qué sí aporta este diseño:** la frecuencia con que se escala, qué se usa y cuánto tarda en retirarse el esteroide, información útil para planear y para diseñar ensayos.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Pacientes consecutivos	Todos los enviados en el periodo, con un diagnóstico de artritis confirmado por ultrasonido y 12 meses de seguimiento.	Confirmado
● Fenotipos definidos	Separación clara entre artritis (± polimialgia) y polimialgia sola.	Confirmado
● Retrospectivo y pequeño	68 pacientes; solo 18 con polimialgia.	Reconocido por los autores
● Sesgo de envío	Probable sobrerrepresentación de casos graves.	Reconocido por los autores
● Escala de actividad	Grados CTCAE sin un índice compuesto validado; el ultrasonido no se usó para graduar.	Reconocido por los autores
● Sin desenlaces oncológicos	No se evaluó el efecto de la inmunosupresión sobre el cáncer.	Reconocido como pregunta abierta
● Inconsistencias de reporte	Porcentajes de escalamiento que no corresponden al denominador de 50; el 72 % de la polimialgia a 12 meses aparece como "remisión" y como "remisión o baja actividad"; anticuerpos con datos faltantes.	No comentado

Pregunta de repaso: hombre de 72 años con melanoma metastásico en pembrolizumab, con sinovitis de MCF y carpos confirmada por ultrasonido. Con prednisolona 15 mg/día mejora, pero recae cada vez que baja de 10 mg. ¿Qué aporta este estudio?
Respuesta. Que su evolución es la habitual en la artritis por inhibidor de checkpoint: en esta serie, ~la mitad necesitó un FARME, sobre todo metotrexato o tocilizumab, y a 12 meses el 64 % estaba en remisión y el 50 % sin esteroide.[1] Eso apoya plantear pronto un ahorrador de esteroide junto con oncología, como sugieren los puntos a considerar de EULAR 2021 que el artículo cita. Pero el estudio no demuestra que los FARME causaran la mejoría ni informa su efecto sobre el melanoma, así que la decisión de seguir o suspender la inmunoterapia y la elección del fármaco deben tomarse con el oncólogo.

¿Qué aprendí de medicina?

- Polimialgia por inhibidor: suele bastar el esteroide a dosis bajas.
- Artritis por inhibidor: ~la mitad escaló a FARME (metotrexato, tocilizumab).
- La artritis llevó más a suspender la inmunoterapia (46 % vs. 11 %).
- Falta saber el efecto de escalar sobre el control del cáncer.

¿Qué aprendí de investigación?

- Sin comparador, "mejoró tras el fármaco" no prueba eficacia.
- Se escala en el peor momento: regresión a la media.
- Confusión por indicación entre tratados y no tratados.
- Revisa siempre qué desenlace importante falta.

6 Referencias

1. Liapi M, Dastmalchi M, Svedman FC, Chatzidionysiou K. Treatment patterns and outcomes of immune checkpoint inhibitor-induced inflammatory arthritis and polymyalgia rheumatica: a single-centre observational study. RMD Open. 2026;12:e007219. doi:10.1136/rmdopen-2026-007219

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.